Bài 5 CHẢY MÁU ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Trịnh Văn Tuấn

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Nắm được các cách tiếp cận, thăm khám, phân loại, chỉ định thăm dò, chẩn đoán và chỉ định điều trị chảy máu đường tiêu hóa.

2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt chảy máu đường tiêu hóa.

3. Trình bày được nguyên tắc điều trị, chỉ định điều trị nội khoa bao gồm điều trị thuốc, nội soi, can thiệp mạch và và các phương pháp phẫu thuật chảy máu đường tiêu hóa.

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. ĐẠI CƯƠNG

Chảy máu đường tiêu hóa (CMĐTH) là một cấp cứu thường gặp với các biểu hiện lâm sàng rất đa dạng. Chảy máu có thể ở mức độ nhẹ, trung bình, nặng và có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trong ống tiêu hóa từ miệng tới ống hậu môn, bao gồm cả ở các tuyến phụ thuộc như gan, mật và tụy. Ở Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh CMĐTH hàng năm khoảng 170/100.000 người trưởng thành với hơn 300.000 ca nhập viện hàng năm. Tần suất bệnh chiếm tỷ lệ khoảng từ 1-2% tổng số cấp cứu nhập viện và tăng dần theo tuổi, nam gặp nhiều hơn nữ. Ở nước ta, chảy máu ở đường tiêu hóa trên gặp nhiều hơn gấp 4 lần so với đường tiêu hóa giữa và dưới, trong đó chảy máu do viêm, loét dạ dày-tá tràng chiếm tới 80% số trường hợp. Tỷ lệ mắc bệnh theo giới cũng khác biệt, ở nam là 60%, nữ là 40%. Sở dĩ nam giới bị bệnh nhiều hơn nữ giới chủ yếu là do nam giới sử dụng rượu, bia, thuốc lá và ăn uống không điều độ.

Hầu hết bệnh nhân bị CMĐTH có thể tự ngừng chảy máu. Tuy nhiên vẫn có tới 15% số trường hợp chảy máu nặng, cần thiết phải hồi sức, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời để giảm bớt tỷ lệ tử vong. Chỉ định nội soi ngay trong 24 giờ đầu khi nhập viện để chẩn đoán nguyên nhân chảy máu và can thiệp kịp thời đã giảm đáng kể số ca phải điều trị phẫu thuật, tiết kiệm chi phí và thời gian nằm viện. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong do CMĐTH vẫn còn cao vì những lý do khác nhau như bệnh phát hiện muộn, xử trí ban đầu chưa đúng, điều trị chưa kịp thời...

II. ĐỊNH NGHĨA

- CMĐTH là tình trạng máu chảy ra khỏi lòng mạch vào đường tiêu hóa từ miệng tới hậu môn, được thải ra ngoài qua nôn ra máu, ỉa ra phân có máu đỏ hoặc đen.

- Là cấp cứu thường gặp trong thực hành lâm sàng kể cả nội khoa hoặc ngoại khoa. CMĐTH là biến chứng của nhiều loại bệnh.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- CMĐTH có thể ở mức độ nhẹ, khỏi tự nhiên hoặc ở mức độ nặng, có thể gây sốc không hồi phục dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu không có phác đồ xử trí và điều trị kịp thời.

III. PHÂN LOẠI

Theo các xuất bản gần đây trên các tạp chí y học thế giới, CMĐTH được chia làm ba loại:

- *Chảy máu đường tiêu hóa trên* (CMĐTHT): Là những trường hợp chảy máu từ bóng Valter trở lên, nguyên nhân gây chảy máu thường do loét dạ dày - tá tràng, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, chảy máu đường mật, ung thư....

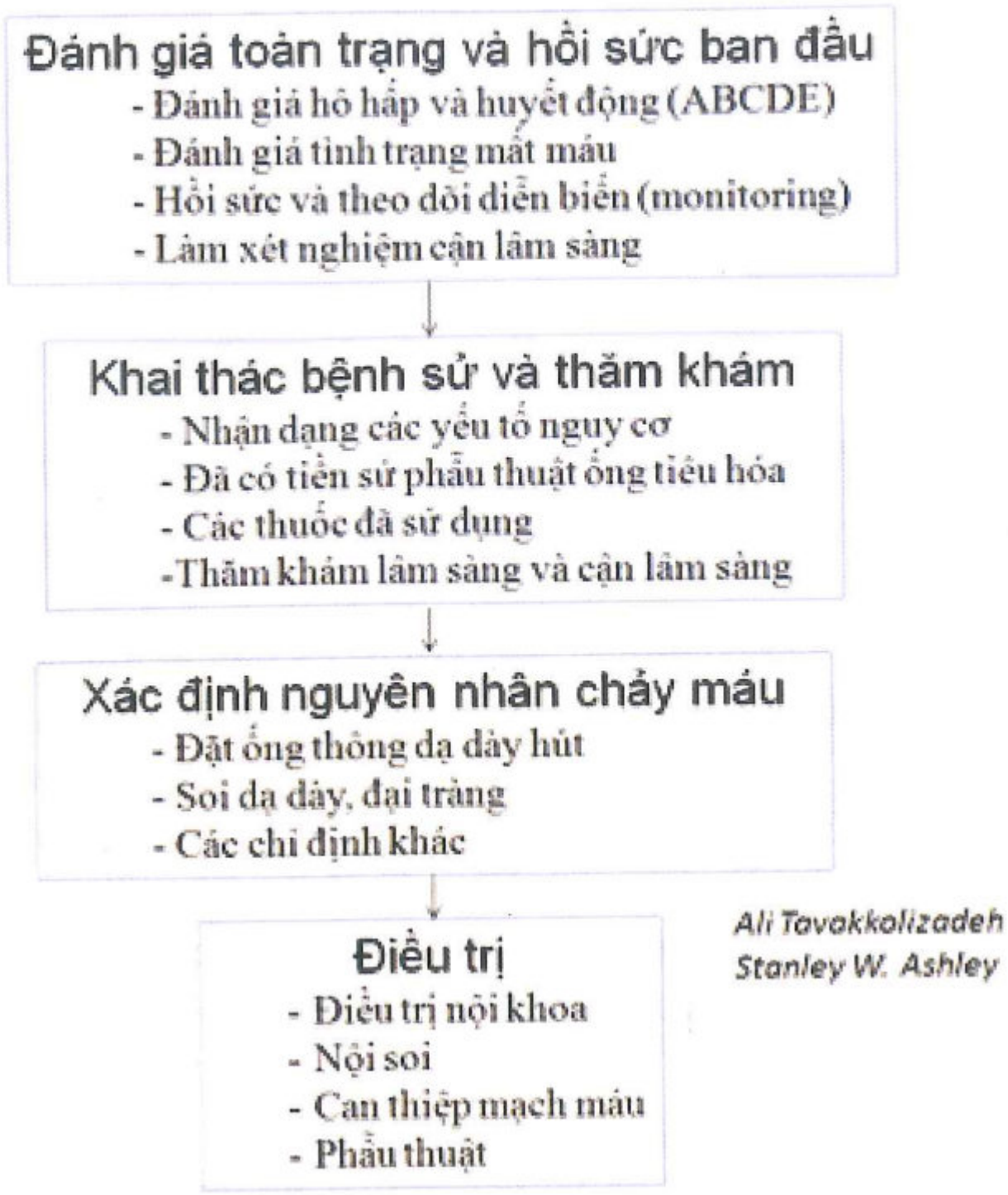
- *Chảy máu đường tiêu hóa giữa* (CMĐTHG): Là những trường hợp chảy máu từ dưới bóng Vater tới góc hồi manh tràng hay chảy máu ở ruột non, thường do u; polyp; dị dạng mạch (hội chứng Dieulafoy); viêm ruột... CMĐTHG chiếm tỷ lệ nhỏ trong tất cả các trường hợp CMĐTH. Tuy nhiên CMĐTHG khó kiểm soát hơn CMĐTHT hoặc CMĐTHD do khả năng phát hiện hạn chế. Nguyên nhân chảy máu, dấu hiệu lâm sàng, chẩn đoán và xử trí rất khác nhau giữa người trẻ và người cao tuổi. Gần đây, sử dụng nội soi viên nang hoặc nội soi hỗ trợ thiết bị (nội soi hỗ trợ bóng đơn, bóng kép, nội soi xoắn ốc…) đã giúp cải thiện rất lớn khả năng chẩn đoán, góp phần cải thiện chất lượng điều trị và tiên lượng cho loại bệnh lý này.

- *Chảy máu đường tiêu hóa dưới* (CMĐTHD): Là những trường hợp chảy từ góc hồi manh tràng trở xuống hay chảy máu ở đại tràng, nguyên nhân thường gặp là u, polyp, viêm túi thừa, trĩ...

IV. TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH

Tiếp nhận bệnh nhân CMĐTH phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán và xử trí ban đầu. Tiếp cận sớm với người bệnh giúp cán bộ y tế xác định được khởi đầu và diễn biến của bệnh, nhanh chóng đánh giá mức độ chảy máu nặng có thể xảy ra, nhất là khi tình trạng huyết động và các dấu hiệu toàn thân của người bệnh không ổn định. Với những trường hợp chảy máu nặng, cần tiến hành hồi sức sớm và thiết lập các biện pháp, phương tiện để theo dõi huyết động liên tục, đồng thời khởi động các phương pháp điều trị để kiểm soát và ngăn ngừa chảy máu tái phát.

zalo nhóm duy nhất 0528112107



Hình 1. Các bước tiếp nhận bệnh nhân CMĐTH

1. Đánh giá toàn trạng và hồi sức ban đầu

1.1. Đánh giá tình trạng hô hấp và huyết động

- Đánh giá tình trạng hô hấp: Là ưu tiên hàng đầu khi tiếp nhận người bệnh. Hô hấp phụ thuộc vào hai yếu tố:

+ Đường thở: Là một hệ thống ống, từ mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản đi vào hai lá phổi. Nếu đường này bị cản trở do đờm, rãi, dị vật… thì hô hấp của người bệnh sẽ bị hạn chế hoặc tắc nghẽn. Vì vậy khi tiếp nhận, nếu người bệnh đang trong tình trạng nặng, tri giác giảm thì cần kiểm tra và khơi thông đường thở bằng cách nới rộng quần áo, hút đờm rãi, đặt canul Mayor để tránh lưỡi tụt ra sau che lấp đường thở.

+ Thông khí phổi: Là sự trao đổi O_2 từ không khí vào phế nang và đưa CO_2 từ phế nang ra ngoài cơ thể qua hoạt động thở. Quá trình trao đổi này có thể bị cản trở do các bệnh ở phổi hoặc người bệnh trong tình trạng sốc mất máu. Đánh giá thông khí phổi thường dựa vào tần số thở, nhịp tim và sự hoạt động của các cơ hô hấp. Khi thông khí suy giảm thì tần số thở và nhịp tim tăng lên, co kéo các cơ hô hấp. Giám sát quá trình thông khi bằng cách theo dõi phân áp pO_2 trên monitoring để quyết định có phải hỗ trợ hô hấp hay không (thở O_2, đặt nội khí quản…).

- Đánh giá tình trạng huyết động: Khi hô hấp được đảm bảo thì tình trạng huyết động của bệnh nhân trở thành mối quan tâm chính. Đánh giá tình trạng huyết động dựa

zalo nhóm duy nhất 0528112107

vào nhịp tim hoặc nhịp mạch ngoại vi, huyết áp, màu sắc da và nhiệt độ chi thể. Khi tình trạng huyết động suy giảm trong trường hợp CMĐTH nặng thì tần số tim biến động sớm nhất, huyết áp giảm, màu sắc da mất hồng và đầu chi lạnh. Cần lưu ý với những người bệnh béo phì, tình trạng kích động hoặc có tiền sử hạ huyết áp (huyết áp tâm thu <90 mmHg ở tư thế nằm ngửa), nhất là ở bệnh nhân lớn tuổi có dùng thuốc chẹn beta.

Nhìn chung, khi tiếp cận người bệnh, đánh giá tình trạng hô hấp và huyết động ban đầu cần dựa vào quy tắc ABCDE (A: airway - đường thở; B: breath - thông khí phổi; C: circulation - tuần hoàn; D: disable - tri giác; E: expose - các bệnh kèm theo).

1.2. Đánh giá mức độ chảy máu

Máu thoát ra từ mạch vào trong ống tiêu hóa sẽ gây nên những thay đổi huyết động trên lâm sàng. Mức độ chảy máu được chia thành ba loại: Chảy máu nhẹ, trung bình và nặng.Theo Cappell MS, Friedel D. (2008) [7], cơ sở để phân loại chảy máu dựa và các chỉ tiêu sau (bảng 1):

Bảng 1. Phân loại chảy máu theo Cappell MS, Friedel D. (2008).

Chỉ tiêu	Phân loại chảy máu		
	Nhẹ	Trung bình	Nặng
Lượng máu mất	<1000ml	1000 - 2000ml	>2000ml
Huyết áp tâm thu	Bình thường ≥90 mmHg	Thấp 80 - <90 mmHg	Tụt < 80 mmHg
Hạ áp tư thế	Không	Có thể	Chắc chắn
Mạch nhanh	Không 90 - < 100 lần/phút	Vừa phải 100 - 120 lần/phút	Nhiều >120 lần/phút
Da	Ẩm, tưới máu tốt	Đổ mồ hôi	Mát - lạnh, ẩm ướt
Nhịp thở	Bình thường	Bình thường - giảm nhẹ	Bất thường
Nước tiểu	Bình thường	Giảm	Vô niệu
Tri giác	Tỉnh/lo âu	Lo âu	Lẫn lộn/ngủ gà

Tuy nhiên, để xác định ba mức độ chảy máu còn tùy thuộc vào từng phương pháp đánh giá.

1.2.1. Dựa vào hỏi bệnh

Hỏi người bệnh hoặc người trong gia đình số lượng máu mất qua nôn, qua phân nếu bệnh nhân không tỉnh:

- Nhẹ: Lượng máu mất dưới 500ml
- Trung bình: Lượng máu mất từ 500ml - 1000ml
- Nặng: Lượng máu mất trên 1000ml

Đánh giá mức độ mất máu theo phương pháp này chỉ có giá trị ước lượng, không chính xác nhưng có thể thực hiện được trong hoàn cảnh cách xa cơ sở y tế,

zalo nhóm duy nhất 0528112107

không có phương tiện hỗ trợ thăm khám và chẩn đoán nào khác. Có thể kết hợp với đếm tần số mạch để hạn chế thiếu sót của phương pháp này. Sở dĩ số lượng máu mất được phân loại qua hỏi bệnh thấp hơn phân loại của Cappel và Friedel là vì máu chảy còn giữ lại một lượng lớn trong ống tiêu hóa nên lượng máu qua nôn, qua phân chỉ là ước lượng tương đối.

1.2.2. Dựa vào thăm khám và xét nghiệm máu

Thăm khám tình trạng toàn thân, chỉ số mạch và huyết áp kết hợp với xét nghiệm huyết học để phân loại mức độ chảy máu (Bảng 2).

Bảng 2. Đánh giá mức độ chảy máu dựa vào lâm sàng và công thức máu.

Chỉ số	Mức độ mất máu		
	Nhẹ	Trung bình	Nặng
Toàn thân	Bình thường	Hoa mắt, chóng mặt	Sốc
Hồng cầu (HC)	>3,5 triệu/mm^3	2,5-3,5 triệu/mm^3	<2,5 triệu/mm^3
Hemoglobin (Hb)	>10 g/l	9-10 g/l	<9 g/l
Hematocrit (Hct)	>35%	30-35%	<30%
Mạch	80 lần/phút	100-120 lần/phút	>120 lần/phút
Huyết áp tối đa	>100 mHg	90 - 100 mHg	<80 mHg

1.2.3. Dựa vào nội soi đường tiêu hóa

Nội soi đường tiêu hóa trong cấp cứu vừa để đánh giá mức độ chảy máu, chẩn đoán nguyên nhân, vừa để thực hiện điều trị chảy máu bằng các thủ thuật như tiêm xơ, kẹp clip, đốt, thắt vòng cao su… Nội soi cấp cứu CMĐTH chỉ có thể thực hiện được với CMĐTHT và CMĐTHD. Đối với CMĐTHG, rất khó thực hiện được nội soi trong cấp cứu bằng các phương pháp nội soi thông thường. Tùy từng nguyên nhân gây CMĐTH lại có cách đánh giá mức độ mất máu khác nhau như Forrest (loét dạ dày - tá tràng), OV (búi giãn tĩnh mạch thực quản), chảy máu ở trực tràng, trĩ…

Đánh giá mức độ chảy máu do loét dạ dày-tá tràng dựa vào nội soi là cách đánh giá chảy máu động, nghĩa là quan sát thấy thương tổn có chảy máu hay không còn chảy, khác với cách đánh giá dựa vào khám lâm sàng và xét nghiệm huyết học. Nếu người bệnh được soi sớm ngay trong những giờ đầu mà thấy máu đang chảy thì chưa chắc trên lâm sàng và xét nghiệm huyết học đã có thay đổi tương xứng. Ngược lại, khi nội soi không thấy có hình ảnh chảy máu nhưng vẫn có thể có những biến đổi nặng trên lâm sàng và xét nghiệm huyết học.

1.3. Hồi sức và theo dõi diễn biến chảy máu

1.3.1. Hồi sức: Dựa vào đánh giá tình trạng hô hấp, huyết động và mức độ mất máu để tiến hành hồi sức.

- Nguyên tắc: Chảy máu càng nặng thì hồi sức ban đầu càng phải khẩn trương và tích cực để:

zalo nhóm duy nhất 0528112107

+ Tránh nguy cơ suy đa tạng

+ Hạ thấp tỷ lệ biến chứng và tử vong

- Hồi sức bao gồm:

+ Khai thông đường thở, hỗ trợ và duy trì hô hấp tốt bằng cách hút đờm rãi, đặt canul Mayo, thở O_2, đặt nội khí quản, bóp bóng….

+ Ổn định tuần hoàn bằng truyền dịch, truyền máu hoặc các dung dịch thay thế máu. Áp lực của động mạch phụ thuộc vào độ nhớt của máu, thể hiện qua hematocrit (Hct). Trong CMĐTH, không nên đưa Hct như giá trị bình thường vì như vậy lại tăng nguy cơ chảy máu. Do đó chỉ cần duy trì Hct ≥ 30% ở người già và Hct ≥ 20% ở người trẻ.

+ Đặt thông dạ dày vừa để tránh trào ngược vừa để quyết định các thăm dò cận lâm sàng khác để chẩn đoán nguyên nhân chảy máu và can thiệp điều trị.

+ Thông tiểu để đánh giá chức năng lọc nước tiểu của thận.

+ Thuốc cầm máu như vitamin K, vasopressin…

1.3.2. Theo dõi diễn biến

Theo dõi diễn biến CMĐTH dựa vào:

- Các chỉ số sinh tồn: Mạch, huyết áp, nhịp thở, số lượng nước tiểu…

- Tình trạng chảy máu: Qua ống thông dạ dày, qua phân…

- Các xét nghiệm huyết học: Hồng cầu, Hb, Hct, xét nghiệm đông máu và sinh hóa...

1.4. Xét nghiệm và thăm dò cấp cứu

- Các xét nghiệm huyết học, đông máu và sinh hóa cần làm ngay trong quá trình hồi sức.

- Các thăm dò hình ảnh (nội soi đường tiêu hóa, chụp mạch…) phụ thuộc vào tình trạng huyết động và mức độ chảy máu. Nhiều trường hợp chảy máu nặng phải vừa hồi sức vừa thực hiện các thăm dò để cầm máu như nội soi đường tiêu hóa để tiêm xơ, kẹp clip, thắt vòng cao su, đốt điện… hoặc chụp mạch để nút mạch.

2. Khai thác bệnh sử và thăm khám

2.1. Các yếu tố nguy cơ

CMĐTH sẽ tăng nguy cơ trong những trường hợp:

- Tuổi >60

- Bệnh phối hợp:

+ Suy thận

+ Bệnh gan

+ Suy hô hấp

+ Bệnh tim

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Tình trạng xuất huyết:

+ Áp lực tâm thu <100mHg

+ Có chỉ định phải truyền máu

- Chảy máu dai dẳng hoặc tái diễn

- Chảy máu trong khi nằm viện

- Cần thiết phải phẫu thuật

2.2. Tiền sử phẫu thuật ống tiêu hóa

- Do các bệnh lành tính: Thủng loét dạ dày - tá tràng, viêm ruột thừa, trĩ, tắc ruột, chấn thương, polyp…

- Do các bệnh ác tính: Các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

2.3. Các thuốc đã sử dụng

- Các thuốc giảm đau, kháng viêm không corticoid (NSAIDs).
- Corticoid, các thuốc điều trị nội tiết, điều trị ung thư...
- Tiếp xúc với các hóa chất độc hại, phóng xạ…

2.4. Thăm khám lâm sàng

2.4.1. Khai thác bệnh sử

- Có tiền sử CMĐTH trước đó
- Tiền sử uống rượu; viêm gan B,C
- Sử dụng thuốc NSAIDs
- Các bệnh về gan
- Các biểu hiện tiền ung thư
- Rối loạn tiêu hóa, ỉa ra máu
- Có loét đường tiêu hóa

2.4.2. Triệu chứng cơ năng

- Triệu chứng chính là nôn ra máu, ỉa phân đen (CMĐTHT và CMĐTHG) hoặc ỉa ra máu đỏ (CMĐTHD)
- Hoa mắt chóng mặt
- Tri giác giảm nếu chảy máu nặng

2.4.3. Thăm toàn thân

- Da và niêm mạc nhợt
- Mạch nhanh là dấu hiệu sớm nhất trong CMĐTH, huyết áp tụt
- Tiểu ít do giảm áp lực lọc ở cầu thận.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

2.4.4. Thăm khám thực thể

- Có tuần hoàn bàng hệ
- Lách to, gan to
- Có khối u ở bụng
- Tam chứng Charcot
- Trĩ, polyp và các khối u ở trực tràng
- Thăm trực tràng có máu hoặc có phân đen. Đôi khi có thể sờ thấy khối u trực tràng hoặc trĩ chảy máu.

2.5. Cận lâm sàng

2.5.1. Xét nghiệm máu

- Xét nghiệm huyết học: Hồng cầu, Hb, Hct, tiểu cầu
- Xét nghiệm đông máu: Prothrombin, thời gian máu chảy (TS), thời gian máu đông (TC), thời gian prothrombin (PT), fibrigogen…
- Xét nghiệm sinh hóa.

2.5.2. Chẩn đoán hình ảnh

- Nội soi: CMĐTHT soi dạ dày-tá tràng; CMĐTHD soi đại tràng; CMĐTHG nội soi viên nang hoặc nội soi hỗ trợ thiết bị (bóng đơn, bóng kép, nội soi xoắn ốc…)
- Chụp mạch máu

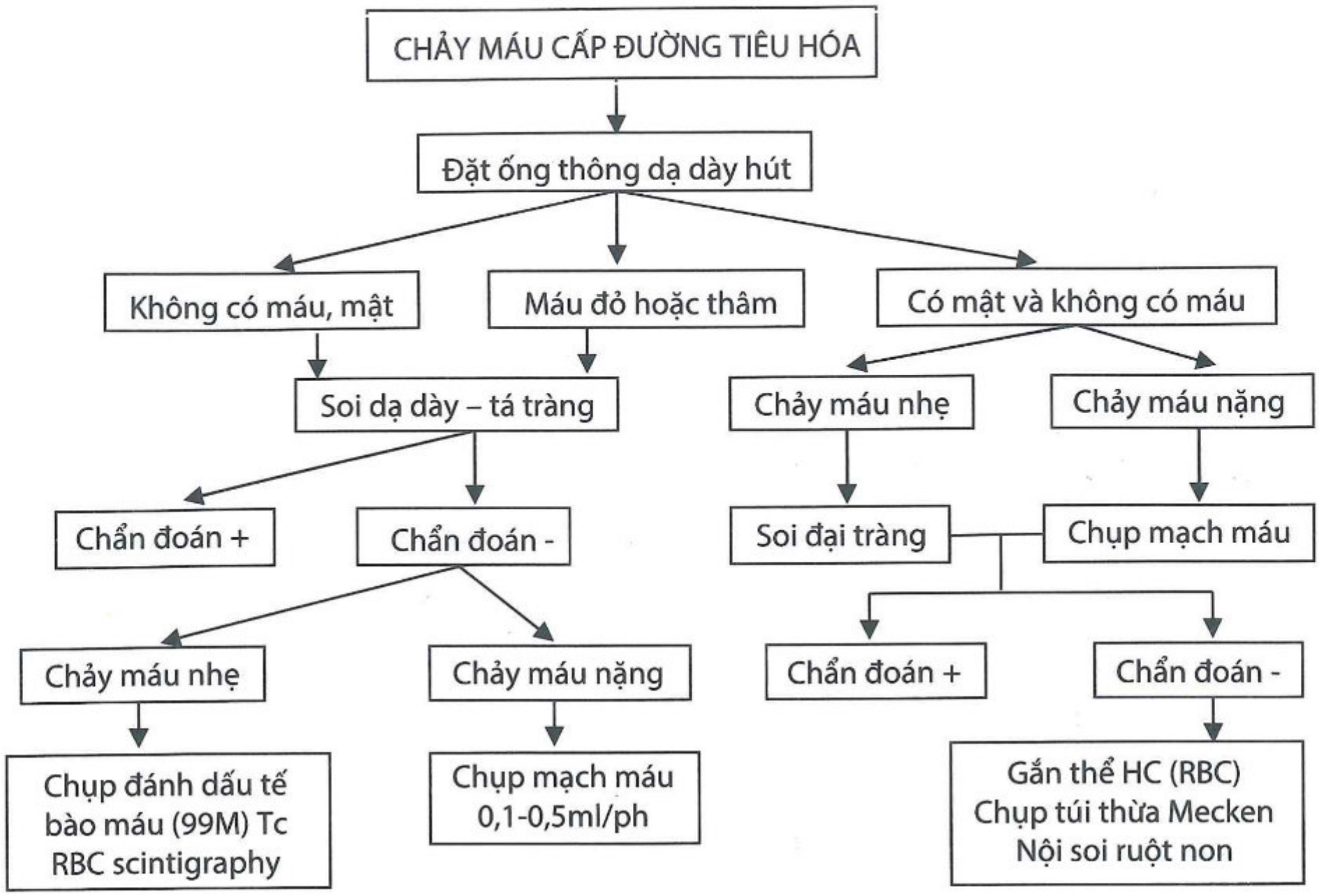
3. Chẩn đoán

Chẩn đoán CMĐTH dựa vào dấu hiệu lâm sàng, xét nghiệm máu và thăm dò hình ảnh. Theo Ali Tavakkolizadeh và Stanley W. Ashley (textbook of surgery 2012),có thể dựa vào kết quả hút dịch dạ dày để lựa chọn các thăm dò hình ảnh thích hợp để chẩn đoán nguyên nhân chảy máu ở bất cứ đoạn nào trong ống tiêu hóa (Hình 4).

Theo sơ đồ trên, đặt ống thông dạ dày ngoài mục đích chống trào ngược còn giúp đánh giá và chỉ định các thăm dò hình ảnh thích hợp để chẩn đoán vị trí chảy máu trong ống tiêu hóa:

- Bình thường dịch mật không có trong dạ dày vì do cơ môn vị ngăn cách dạ dày và tá tràng nên không có hiện tượng nước mật trào lên dạ dày. Trong CMĐTH, khi ống thông dạ dày hút ra không có dịch mật, không có máu (1) hoặc có máu (2) thì chỉ định soi dạ dày là thăm dò được lựa chọn.
- Khi hút ống thông dạ dày có nước mật nhưng không có máu (3), nghĩa là có thương tổn chảy máu ở dưới cơ môn vị. Nếu máu chảy nhiều, máu cục làm cản trở lưu thông trong lòng ruột dẫn đến áp lực trong lòng ruột tăng lên khiến nước mật trào ngược lên dạ dày. Chỉ định soi đại tràng, soi ruột non hoặc chụp mạch mạc treo là những thăm dò được lựa chọn.

zalo nhóm duy nhất 0528112107



Ali Tavakkolizadeh và Stanley W.Ashley

Hình 2. Lựa chọn các thăm dò hình ảnh

4. Điều trị

Điều trị CMĐTH tùy thuộc vào mức độ và vị trí chảy máu. Có thể chỉ định theo thứ tự:

- Điều trị nội khoa: Truyền dịch, truyền máu hoặc các dung dịch thay thế máu; kháng sinh chống bội nhiễm; thuốc cầm máu và thuốc chống loét. Nhịn ăn, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

- Nội soi: Chỉ định nội soi sớm trong 24 giờ đầu nhập viện để chẩn đoán nguyên nhân chảy máu và can thiệp cầm máu bằng tiêm xơ, kẹp clip, đốt điện…

- Can thiệp mạch: Khi không thể cầm máu được qua nội soi hoặc khó khăn trong xác định vị trí chảy máu. Lưu ý khi can thiệp mạch ở ống tiêu hóa dễ gây nên hoại tử, nhất là ở ruột non và đại tràng.

- Phẫu thuật: Chỉ đặt ra khi các chỉ định điều trị nêu trên thất bại (xem chỉ định trong từng bệnh cụ thể).

V. CHẢY MÁU ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN (CMĐTHT)

1. Định nghĩa

Là chảy máu do các thương tổn từ miệng tới bóng Vater, biểu hiện trên lâm sàng là nôn ra máu, ỉa phân đen hoặc cả nôn ra máu và ỉa phân đen.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

2. Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân gây nên CMĐTHT nhưng ba nguyên nhân thường gặp là:

- Loét dạ dày - tá tràng.
- Viêm dạ dày, viêm tá tràng hoặc viêm dạ dày - tá tràng.
- Vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ gan tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

Ngoài ba nguyên nhân trên còn có thể thấy CMĐTHT do:

- Ung thư dạ dày
- Hội chứng Malory-Weitz
- Chảy máu đường mật
- Viêm thực quản chảy máu
- Túi thừa tá tràng
- Dị dạng mạch (hội chứng Dieulafoy)...

3. Chảy máu do loét dạ dày - tá tràng

Chảy máu là biến chứng của bệnh loét dạ dày - tá tràng, thường gặp nhiều loét tá tràng (27%) hơn so với loét dạ dày (17%).

Xem bài "Chảy máu đường tiêu hóa do loét dạ dày - tá tràng"

4. Chảy máu do viêm dạ dày - tá tràng

4.1. Nguyên nhân

Chảy máu do viêm dạ dày, viêm tá tràng hay viêm dạ dày - tá tràng cũng rất thường gặp trong cấp cứu. Khi thăm khám lâm sàng cần phải xác định hai hoàn cảnh sau:

- Uống các loại thuốc gây tổn thương dạ dày - tá tràng là nguyên nhân thường gặp trong chảy máu do viêm dạ dày - tá tràng. Có thể cùng lúc gây chảy máu hoặc thủng ổ loét dạ dày - tá tràng. Các loại thuốc thường gây chảy máu là: salycilat, aspirin, APC, các thuốc kháng viêm không steroid như voltaren, analgin, profénid... Ngoài ra uống rượu có thể chảy máu do viêm dạ dày cấp tính.
- Các yếu tố chấn thương tinh thần (stress) như: Hôn mê, nhất là trong chấn thương sọ não (cuching ulcer), viêm màng não, u não…
- Suy thận mạn tính hay cấp tính hoặc những trường hợp mổ u xơ tuyến tiền liệt kéo dài.
- Suy gan cấp trong viêm gan, xơ gan.
- Các loại nhiễm trùng nặng, kéo dài như nhiễm trùng huyết, áp xe, viêm tuỵ hoại tử, viêm mủ đường tiết niệu…
- Bỏng, nhất là trong những trường hợp bỏng nặng, kéo dài.

4.2. Chẩn đoán

Tiền sử: Có bệnh lý dạ dày - tá tràng; các bệnh nội khoa như tiểu đường, viêm khớp; sử dụng thuốc corticoid, NSAIDs…

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Lâm sàng: Nôn ra máu, ỉa phân đen tính chất ít khi dữ dội, có thể xuất hiện sau khi uống thuốc.

Nội soi: Xác định dễ dàng các tổn thương viêm, chảy máu ở dạ dày - tá tràng, thường có hình ảnh xuất huyết rải rác hoặc xuất huyết thành từng đám nhưng thường là những viêm trợt (erosion) niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng, đôi khi khu trú ở hang vị, tâm vị.



Hình 3. Viêm chảy máu niêm mạc dạ dày

4.3. Điều trị

* Điều trị nội khoa:

- Rửa dạ dày
- Truyền máu
- Thuốc kháng H_2, PPI
- Thuốc giảm acid dạ dày
- Thuốc giảm co thắt

* Điều trị nguyên nhân:

- Ngừng uống thuốc gây tổn thương dạ dày - tá tràng
- Điều trị trạng thái bệnh lý gây stress.
- Các thuốc an thần giảm đau.

* *Tiêm xơ qua nội soi:*Những trường hợp viêm trợt (ession) rải rác hoặc khu trú ở tâm vị, hang vị thì có thể tiêm xơ cầm máu sau đó điều trị thuốc.

* *Điều trị ngoại khoa:*Chỉ định khi điều trị nội khoa thất bại hoặc chảy máu ở bệnh nhân có loét dạ dày - tá tràng. Có thể cắt dạ dày, cắt dây thần kinh X..., nhất là những nghi ngờ hội chứng dị dạng mạch (Dieulafoy).

5. Chảy máu do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản

5.1. Đại cương

Chảy máu đường tiêu hóa (CMĐTH) do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản chiếm khoảng 30% các nguyên nhân CMĐTH trên, chỉ sau chảy máu do loét dạ dày - tá tràng

zalo nhóm duy nhất 0528112107

nhưng đứng đầu về mức độ chảy máu. Bệnh nhân thường nôn ra máu đỏ tươi, số lượng nhiều, đôi khi máu chảy ồ ạt có thể gây tử vong trước khi được cấp cứu. Nguyên nhân chảy máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản chủ yếu là tăng áp lực tĩnh mạch cửa do xơ gan (90%). Tiên lượng của những bệnh nhân này thường xấu, khoảng 30% tử vong ở lần chảy máu đầu tiên, 70% bệnh nhân sống sót sẽ bị chảy máu tái phát.

Điều trị chảy máu do vỡ búi giãn tĩnh mạch dựa vào nội soi để can thiệp cầm máu bằng tiêm xơ, kẹp clip, thắt vòng cao su… kết hợp với điều trị nội khoa. Điều trị phẫu thuật dự phòng chảy máu chỉ đặt ra khi chảy máu đã ổn định với nhiều loại phẫu thuật khác nhau tùy thuộc vào mức độ xơ gan.

5.2. Định nghĩa

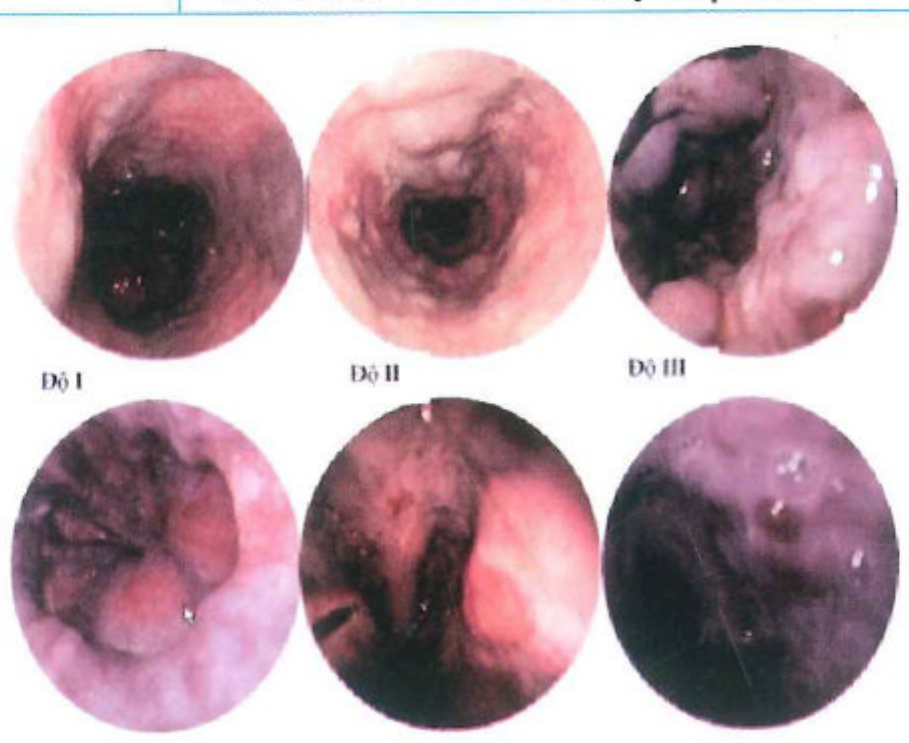
CMĐTH do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản là biến chứng chính của hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Chảy máu thường nặng và đe dọa tử vong. Tuy nhiên, tăng áp cửa không đơn thuần là sự gia tăng áp lực trong hệ thống tĩnh mạch mà là sự gia tăng độ chênh áp lực giữa dòng chảy vào của tĩnh mạch cửa và dòng chảy ra của tĩnh mạch gan (tĩnh mạch trên gan). Nguyên nhân chính gây nên tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa là xơ gan - giai đoạn cuối ở bất kỳ bệnh lý gan mạn nào.

5.3. Phân loại

Theo Hiệp hội nghiên cứu các bệnh về gan Hoa Kỳ (American Association for the Study of Liver Diseases - AASLD) búi giãn tĩnh mạch thực quản được chia thành ba mức độ qua nội soi đường tiêu hóa trên (Bảng 3).

Bảng 3. Phân độ búi giãn tĩnh mạch thực quản theo AASLD

Phân độ AASLD	Mô tả
Độ I (búi giãn nhỏ)	Các tĩnh mạch có kích thước nhỏ, thẳng, biến mất khi bơm hơi căng.
Độ II (búi giãn trung bình)	Các tĩnh mạch có kích thước trung bình, ngoằn ngoèo và chiếm dưới 1/3 khẩu kính của thực quản, không xẹp khi bơm hơi.
Độ III (búi giãn lớn)	Các tĩnh mạch có kích thước lớn, giống khối u chiếm trên 1/3 khẩu kính của thực quản.

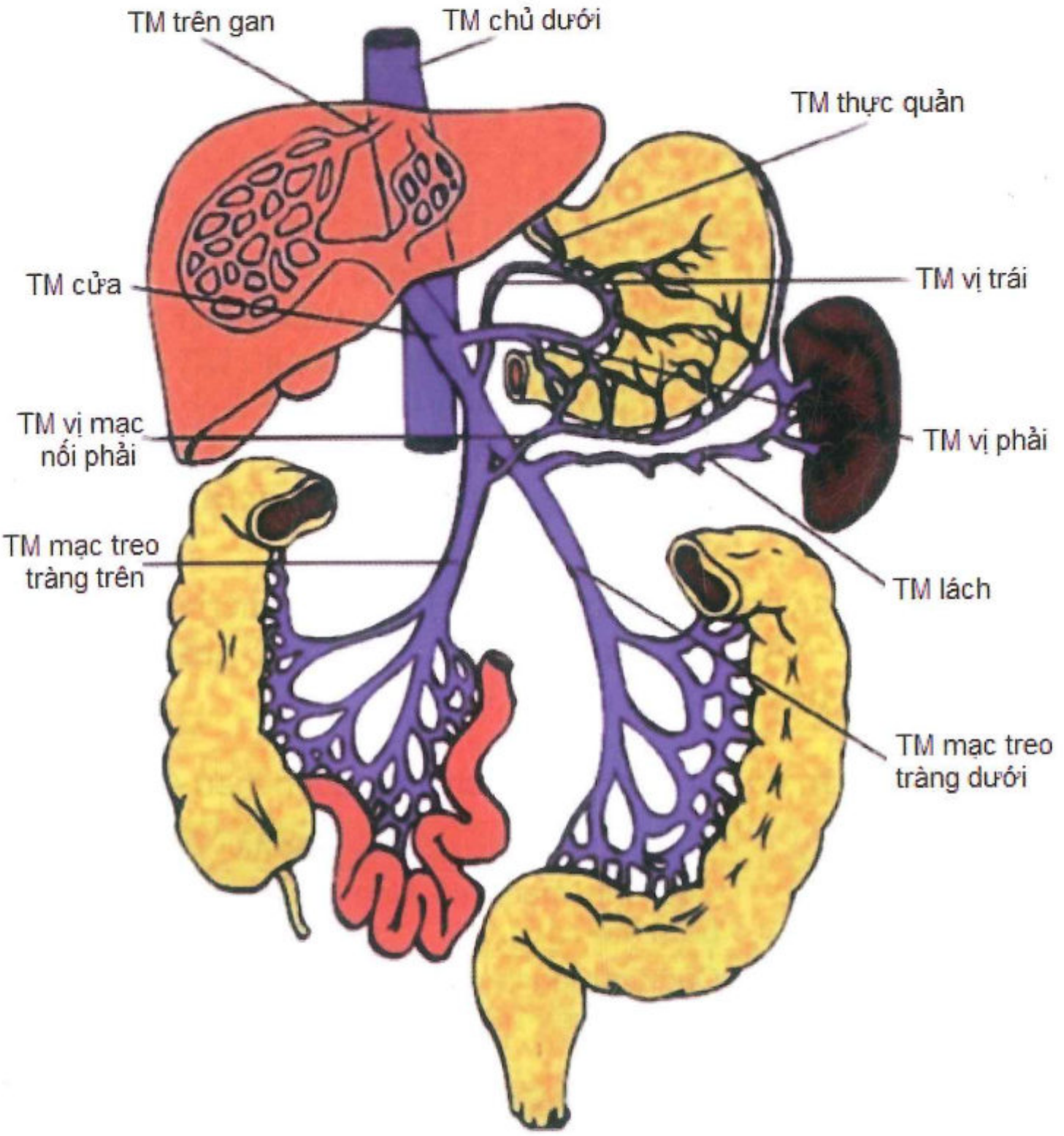


Hình 4. Phân độ giãn tĩnh mạch thực quản qua nội soi

zalo nhóm duy nhất 0528112107

5.4. Sơ lược giải phẫu

Tĩnh mạch cửa hay còn gọi là tĩnh mạch gánh với hai đầu là hai hệ thống mao mạch của gan và ruột, là tĩnh mạch chức phận, nhận máu tĩnh mạch và các chất dinh dưỡng được hấp thu từ ruột. Dòng máu sau đó đi vào gan tới các xoang gan để được chọn lọc, lưu trữ, chế biến và điều hòa rồi được thu thập vào các tĩnh mạch gan để đổ vào tĩnh mạch chủ dưới.



Hình 5. Hệ thống tĩnh mạch cửa

- Hệ thống tĩnh mạch cửa không có van, vì thế đo áp lực là cách chẩn đoán tốt nhất.
- Thành tĩnh mạch cửa dày, chun giãn.
- Các thân chính hình thành nên tĩnh mạch cửa:

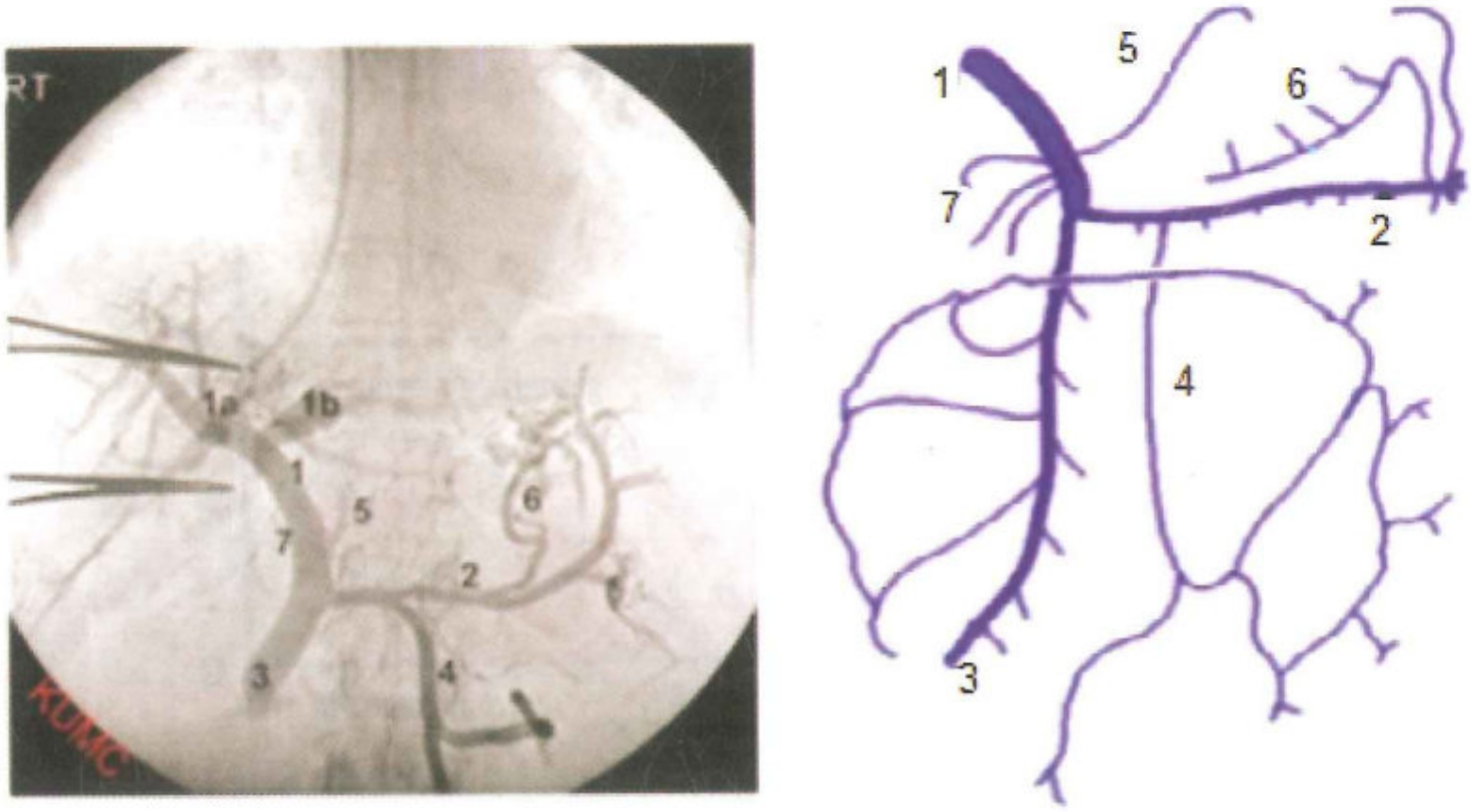
+ Tĩnh mạch lách
+ Tĩnh mạch mạc treo tràng trên (MTTT)
+ Tĩnh mạch mạc treo tràng dưới (MTTD)

- Nhánh phụ:

+ Tĩnh mạch vành vị

zalo nhóm duy nhất 0528112107

+ Tĩnh mạch môn vị
+ Tĩnh mạch vị mạc nối phải
- Vòng nối cửa - chủ tự nhiên
+ Quanh thực quản
+ Quanh trực tràng
+ Quanh rốn
+ Phúc mạc - thành bụng



Hình 6. Hình ảnh chụp mạch và các vòng nối tĩnh mạch cửa

1.Tĩnh mạch cửa; 2.Tĩnh mạch lách; 3.Tĩnh mạch MTTT; 4. Tĩnh mạch MTTD

5.Tĩnh mạch vị trái; 6.Tĩnh mạch vị mạc nối phải; 7.Tĩnh mạch tá tụy

5.5. Bệnh nguyên

Tăng áp lực tĩnh mạch cửa dẫn tới vỡ búi giãn gây CMĐTH trên. Có 4 nguyên nhân dẫn đến tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

5.5.1. Nguyên nhân trước xoang

* Nguyên nhân ngoài gan:
- Huyết khối tĩnh mạch cửa
- Huyết khối tĩnh mạch lách
- Hẹp tĩnh mạch cửa bẩm sinh
- Chèn ép tĩnh mạch cửa từ bên ngoài do u
* Nguyên nhân trong gan:
- Xơ gan bẩm sinh
- Xơ gan mật nguyên phát

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Sán lá gan (Schistosomiasis)
- Bệnh sarcoid

5.5.2. Nguyên nhân tại gan

- Viêm gan nhiễm mỡ (Steatohepatitis)
- Bệnh Wilson

5.5.3. Nguyên nhân sau xoang

* Nguyên nhân trong gan:

- Hội chứng Budd-Chiari
- Xơ gan mật thứ phát
- Xơ gan do rượu (Laennec Cirrhosis)
- Xơ gan sau viêm gan
- Chứng nhiễm sắc tố sắt (Hemochromatosis)

* Nguyên nhân ngoài gan:

- Hội chứng Budd-Chiari
- Tắc nghẽn tĩnh mạch chủ dưới
- Suy tim phải
- Viêm màng ngoài tim co thắt
- Hở van ba lá

5.5.4. Tăng lưu lượng tĩnh mạch cửa

- Rò động - tĩnh mạch cửa
- Rò động - tĩnh mạch vùng quanh tụy
- Lách khổng lồ (Giant Spleenomegaly)

5.6. Sinh lý bệnh

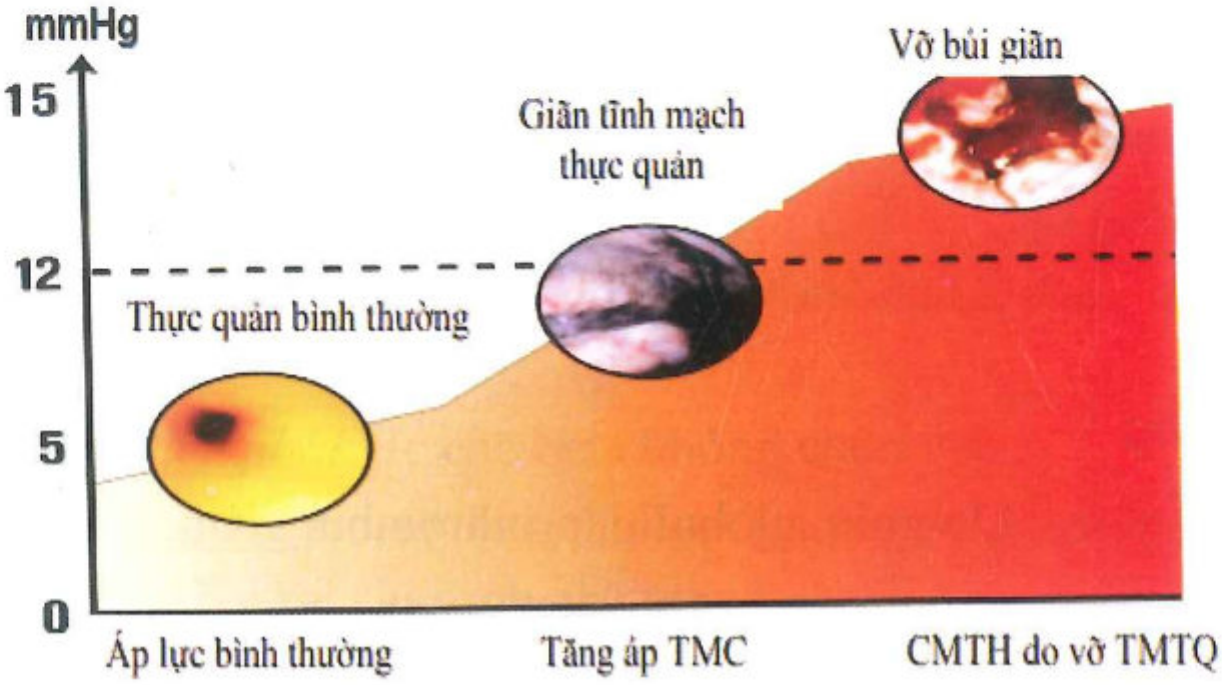
* Áp lực tĩnh mạchcửa phụ thuộc hai yếu tố:

- Sức cản trong gan
- Lưu lượng máu trong hệ cửa
- Đo áp lực tĩnh mạchcửa bằng cách đo áp lực lách hoặc đo áp lực tĩnh mạch gan bằng cách đưa catheter qua tĩnh mạch đùi vào tĩnh mạch gan. Khi đầu catheter vào tĩnh mạch gan và đầu ống thông còn tự do, lúc đó đo được áp lực tĩnh mạch gan tự do (bình thường áp lực tĩnh mạch gan tự do là 9cmH_2O). Tiếp tục đẩy ống thông vào sâu đến khi không còn đẩy được nữa, lúc đó đo được áp lực tĩnh mạch gan bít hay áp lực xoang (bình thường áp lực xoang là l0cmH_2O).

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Bảng 4. Sự thay đổi áp lực của các loại tăng áp lực tĩnh mạch cửa

Nguyên nhân	Áp lực lách	Áp lực TM gan tự do	Áp lực TM gan bít	Chênh lệch áp lực TM gan bít/tự do
Bình thường	10cmH_2O	9cmH_2O	10cmH_2O	0-1cmH_2O
Tắc trước xoang	Tăng nhiều	Bình thường	Bình thường	Bình thường
Tắc tại xoang	Tăng vừa	Bình thường	Tăng	Tăng
Tắc sau xoang	Tăng vừa	Giảm	Tăng	Tăng nhiều
Không tắc	Tăng vừa	Tăng	Tăng	Bình thường



Hình 7. Liên quan giữa áp lực tĩnh mạchcửa, mức độ giãn tĩnh mạch thực quản và CMĐTH

* Tăng áp lực tĩnh mạchcửa khi:

- Áp lực tĩnh mạchcửa>12 mmHg (bình thường 7-12 mmHg)

- Chênh lệch áp lực: cửa - chủ >5 mmHg (bình thường 1-4 mmHg), lách - nhĩ phải >10 mmHg (bình thường 8-10 mmHg).

* Chảy máu do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản là hậu quả bệnh lý của nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là do xơ gan (80%) gây tăng áp lực tĩnh mạchcửa, chiếm khoảng 10% các trường hợp chảy máu đường tiêu hóa trên.

5.7. Chẩn đoán

5.7.1. Lâm sàng

* *Tiền sử:*Viêm gan B, C; nghiện rượu; sốt rét; các bệnh gan…

* *Cơ năng:*

- Theo Napankov (1975), Harissons (1987): Tăng áp lực tĩnh mạchcửa dẫn đến cảm giác khó tiêu sau ăn (bệnh nhân không có bệnh dạ dày), trướng, đầy bụng; giảm cân; thiếu vitamin (ăn uống vẫn đủ, ngon miệng); ỉa chảy có chu kỳ; sốt...

- Các triệu chứng xảy ra từ từ dẫn đến khả năng lao động giảm sút; cảm giác khó chịu, đau thượng vị, hạ sườn phải; chảy máu miệng, lợi...

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Nôn ra máu: Đột ngột, dữ dội, máu đỏ tươi
- Ỉa phân đen

* Toàn thân:

- Nhợt, mạch nhanh, huyết áp hạ
- Sốc nếu mất máu nhiều
- Tri giác giảm, tiền hôn mê gan

* Thực thể:

- Lách to
- Vàng da
- Cổ trướng
- Tuần hoàn bàng hệ
- Trĩ

5.7.2. Cận lâm sàng

- Protein toàn phần: Albumin, globulin, prothrombin giảm.

- Bilirubin, amoniac tăng, AST, ALT, GGT, aFP, glucose, urê, creatinin, điện giải đồ thay đổi.

- Hồng cầu, Hb, Hct, tiểu cầu giảm, bạch cầu tăng.

- Nội soi: Xác định dễ dàng. 90 - 95% tổn thương chảy máu là các búi tĩnh mạch giãn to, căng, phun tia máu đỏ lẫn cục máu đông. Nội soi giúp phân loại mức độ giãn tĩnh mạch thực quản. Khoảng 5% chảy máu từ búi giãn tĩnh mạch ở vùng tâm vị hay phình vị lớn.

- Đo áp lực tĩnh mạch gan, tĩnh mạch lách.

5.7.3. Tiên lượng

Bảng 5. Tiên lượng (Child - Pugh, 1982)

Chỉ số	Điểm Child-Pugh		
	1	2	3
Bệnh não gan	Không có	Thoáng qua hoặc nhẹ	Hôn mê
Cổ trướng	Không có	Có ít	Có nhiều
Bilirubin (mg/dl) hoặc (µmol/l)	<2,0 <35	2,0 - 3,0 35 - 50	>3,0 >50
Albumin (g/dl)	>3,5	2,8 - 3,5	<2,8
Tỷ lệ prothrombin (%) hoặc Thời gian prothrombin (INH)	>64 <1,7	40 - 65 1,7 - 2,3	<44 >2,3

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Child A: 5 - 7 điểm →Tiên lượng tốt.

Child B: 8 - 12 điểm →Tiên lượng dè dặt.

Child C: 13 - 15 điểm →Giai đoạn cuối cùng (giai đoạn mất bù), tiên lượng xấu.

5.8. Điều trị

5.8.1. Điều trị nội khoa

* Nguyên tắc:

- Đặt thông dạ dày, rửa dạ dày bằng nước lạnh.

- Bồi phục khối lượng tuần hoàn, chống sốc.

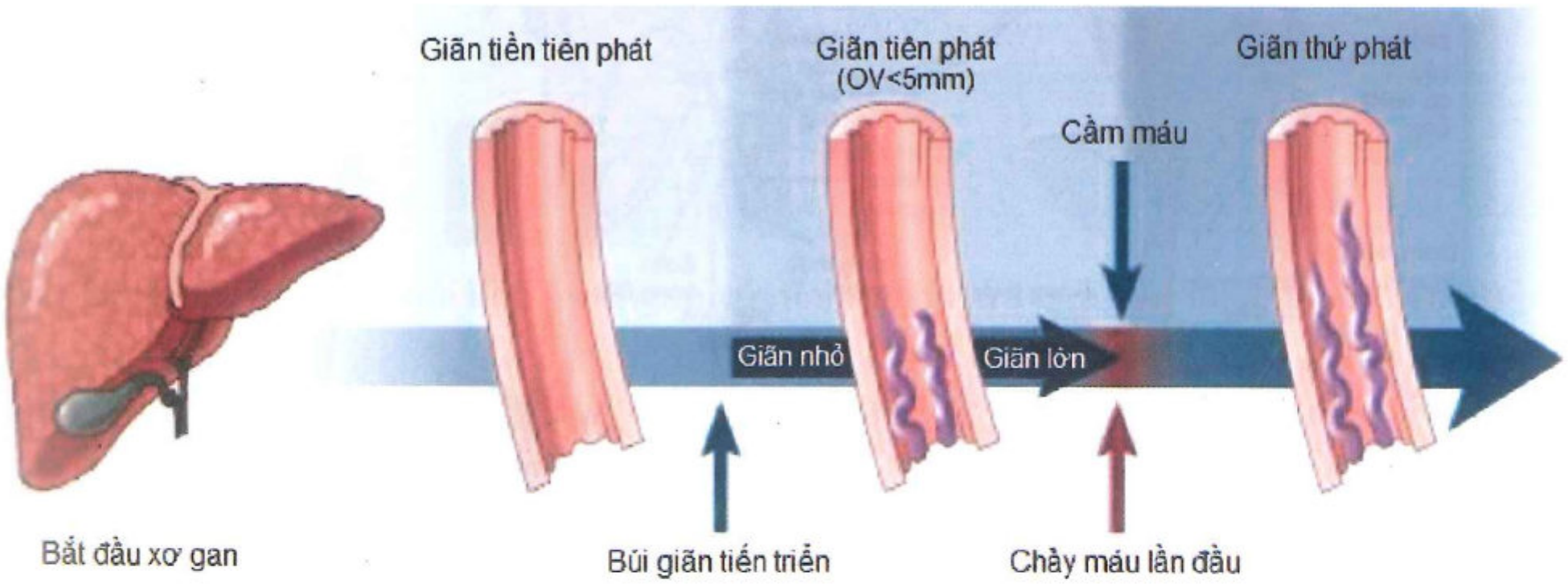
- Nội soi thực quản dạ dày để can thiệp cầm máu hoặc các phương pháp cầm máu khác như dùng ống thông Sengstaken- Blakemore, Minesota để bơm bóng chèn vào búi tĩnh mạch vỡ cầm máu.

- Điều trị dự phòng CMĐTH do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản chia thành ba giai đoạn:

+ *Giai đoạn tiền tiên phát:*Ức chế beta không chọn lọc.

+ *Giai đoạn tiên phát:*Ức chế beta không chọn lọc, giãn mạch nitrat, thắt vòng cao su, tiêm xơ. Nếu thất bại thì chỉ định phẫu thuật tạo shunt.

+ *Giai đoạn thứ phát:*Tiêm xơ, thắt vòng cao su, ức chế beta không chọn lọc, phẫu thuật tạo shunt cửa chủ, TIPS, cắt lách, ghép gan.



Hình 8. Các giai đoạn điều trị dự phòng

- Phòng ngừa các biến chứng:

+ Nhiễm trùng dịch cổ trướng.

+ Hội chứng gan thận.

+ Hội chứng tiền hôn mê gan.

* Điều trị cụ thể:

- Đặt đường truyền tĩnh mạch, để đầu thấp, thở oxy.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Nội soi cầm máu càng sớm càng tốt.

- Truyền khối hồng cầu nếu có thiếu máu.

- Thuốc giảm áp lực tĩnh mạch cửa:

+ Somatostatin: Tiêm tĩnh mạch 250µg, sau đó truyền tĩnh mạch (bơm tiêm điện) liên tục 3mg/12h.

+ Octreotide (sandostatin): Tiêm tĩnh mạch 50µg, đồng thời truyền tĩnh mạch (bơm tiêm điện) liên tục 25µg/h (tương đương 3 ống 100µg/12h). Truyền tĩnh mạch liên tục từ 48 giờ- 5 ngày, nếu phân vàng thì ngừng truyền. Nếu sau 5 ngày còn chảy máu thì nên dừng truyền do không có hiệu quả.

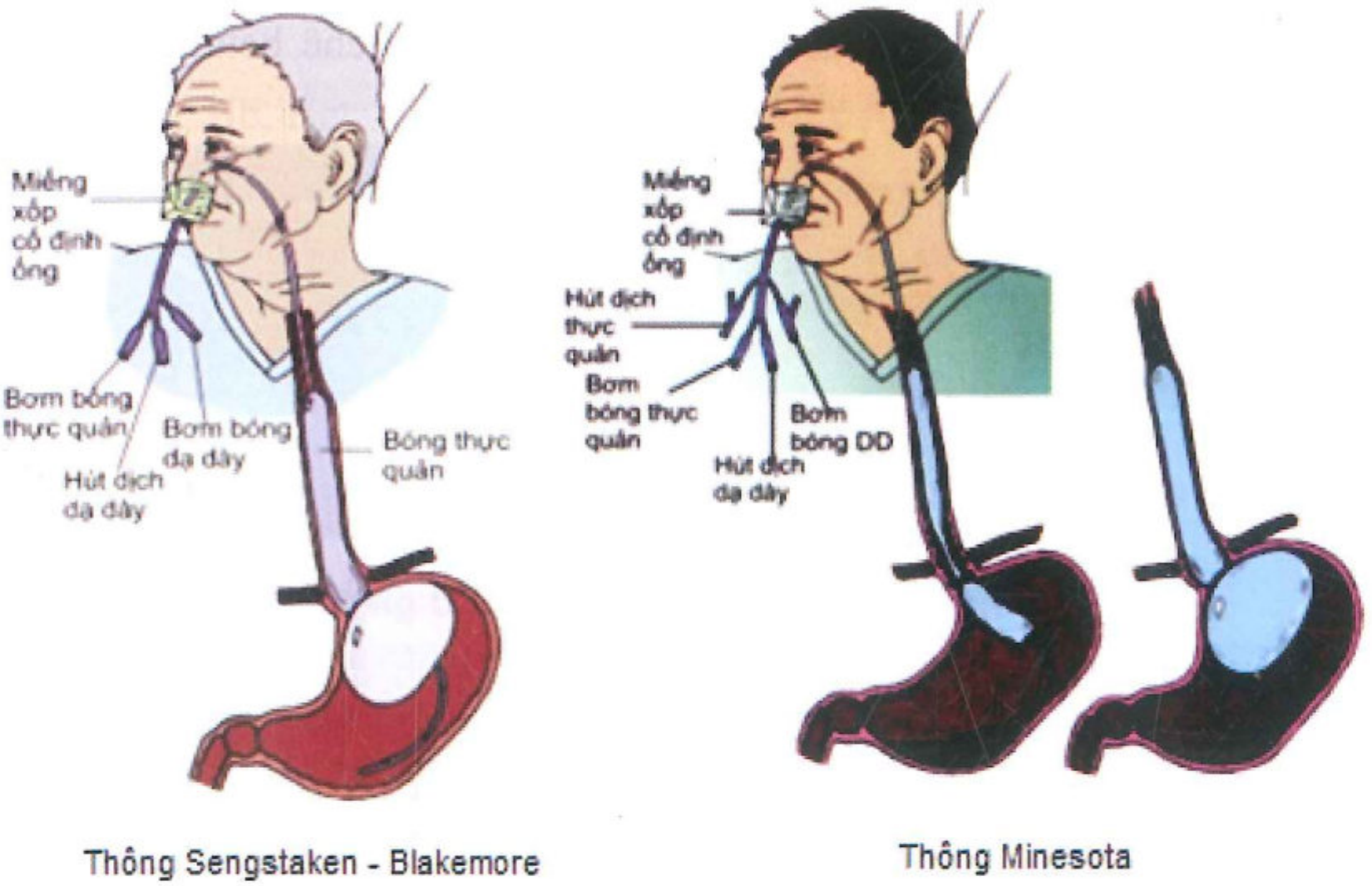
+ Terlipressin (glypressin): Tiêm tĩnh mạchcửa 1mg mỗi 6 giờ, tiêm tĩnh mạch liên tục từ 2 - 5 ngày. Nếu phân vàng thì ngừng truyền.

- Kháng sinh đường ruột: Ciprobay 0,5g x 2viên/ngày dùng 7 ngày; flagyl, neomycin, dùng viên uống nếu bệnh nhân còn uống được, nếu không có thể dùng kháng sinh dự phòng đường tiêm.

- Lactulose đường uống 20 - 50g/24 giờ hoặc thụt tháo.

- Duy trì huyết áp bằng truyền dịch, truyền máu hoặc các dung dịch thay thế máu.

- Theo dõi nhịp thở, huyết động, nhiệt độ, nước tiểu, tình trạng tri giác.



Thông Sengstaken - Blakemore

Thông Minesota

Hình 9. Các loại ống thông sử dụng trong vỡ tĩnh mạch thực quản

* Điều trị duy trì:

- Ngay khi bệnh nhân ngừng chảy máu, kết hợp điều trị giảm áp lực tĩnh mạchcửa bằng thuốc chẹn beta giao cảm không chọn lọc, liều khởi đầu 20mg, tăng dần cho tới khi nhịp tim giảm 25%. Có thể phối hợp chẹn beta giao cảm không chọn lọc với isosorbid mononitrate. Tuy nhiên không dùng isosorbid mononitrate đơn thuần vì không có tác dụng.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Nội soi thắt tĩnh mạch thực quản lại sau 14-21 ngày để dự phòng nguy cơ chảy máu lại. Có thể thắt tĩnh mạch thực quản cho tới khi không còn khả năng thắt được, sau đó cứ 3-6 tháng thì nội soi kiểm tra lại để thắt nếu có các búi giãn xuất hiện.

- Trong trường hợp có giãn tĩnh mạch vùng tâm vị, các búi giãn này liên tục với các búi giãn tĩnh mạch thực quản thì tiến hành tiêm histoacryl tại búi giãn vùng tâm vị, sau đó tiến hành thắt triệt để các búi giãn tại thực quản.

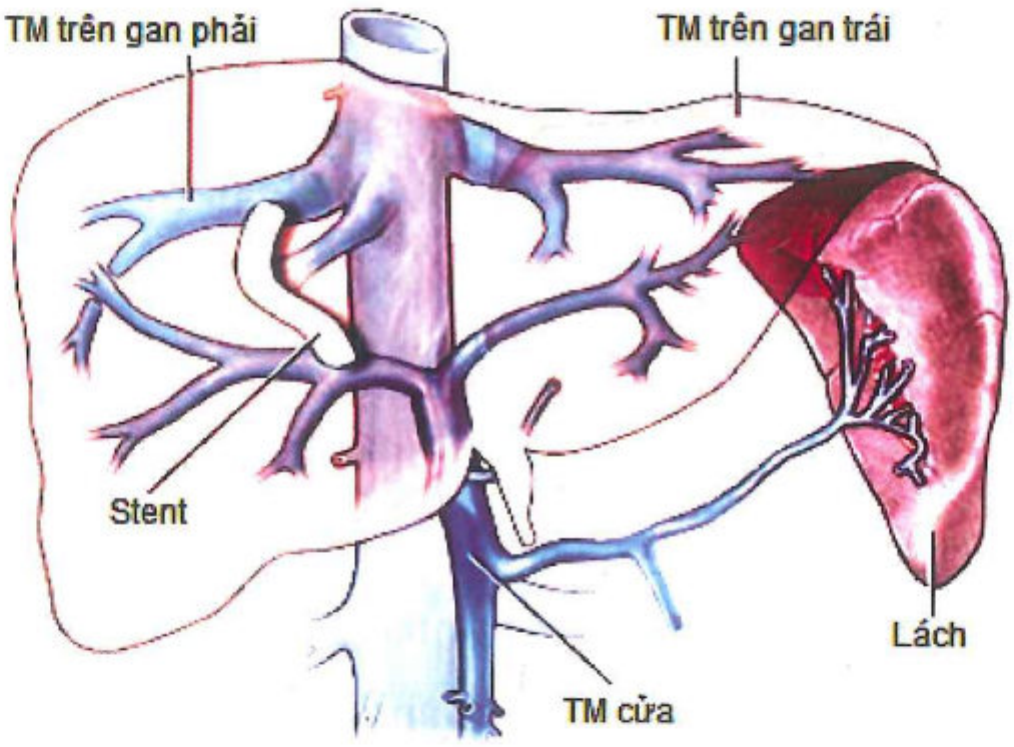
- Bổ sung các yếu tố tạo máu như acid folic, vitamin B12, sắt (chỉ dùng khi xuất huyết tiêu hóa đã ổn định).

5.8.2. Điều trị ngoại khoa

Điều trị ngoại khoa thường được chỉ định sau khi chảy máu ổn định, không chỉ định khi đang chảy máu.

* Phẫu thuật làm giảm áp lực hệ thống tĩnh mạch cửa:

- Nối cửa - chủ qua nhu mô gan (TIPS) bằng can thiệp mạch (Hình 10).



Hình 10. Đặt sten nối tĩnh mạchgan với tĩnh mạchcửa qua can thiệp mạch (TIPS)

- Phẫu thuật phân lưu (Hình 11):

+ Nối cửa-chủ tận bên (hoàn toàn)

+ Nối cửa-chủ bên bên (hoàn toàn)

+ Nối cửa-chủ bằng mạch nhân tạo (bán phần)

+ Nối lách thận (bán phần)

- Giảm dòng máu đến tĩnh mạch cửa:

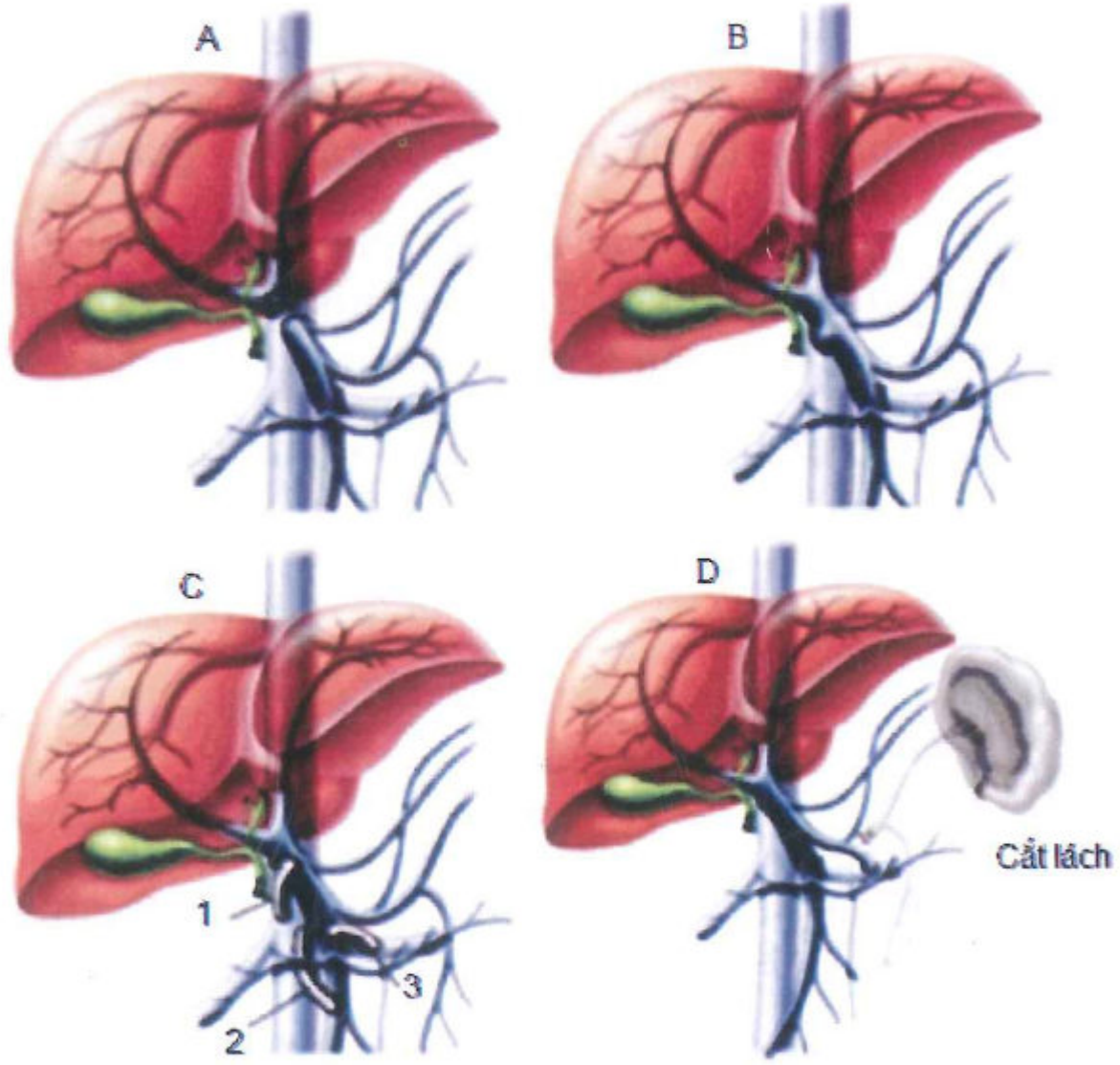
+ Cắt lách

+ Thắt động mạch lách

+ Thắt động mạch gan

+ Phẫu thuật Peter - Womack: Cắt lách, cắt bờ cong lớn dạ dày và thắt 4 cuống mạch của dạ dày.

zalo nhóm duy nhất 0528112107



Hình 11. Các loại phẫu thuật phân lưu (shunt cửa - chủ)

A. Cửa-chủ tận bên; B. Cửa-chủ bên bên; D. Lách-thận;

C. Mạch nhân tạo: 1. Cửa chủ; 2. Mạc treo-chủ; 3. Mạc treo-thận

* *Phẫu thuật điều trị các biến chứng:*

- Điều trị chảy máu do vỡ tĩnh mạch thực quản:

+ Phẫu thuật làm giảm áp lực tĩnh mạchcửa.

+ Phẫu thuật can thiệp trực tiếp lên tĩnh mạch thực quản bị giãn.

+ Phẫu thuật Crile: Mở dọc thực quản, khâu cầm máu các tĩnh mạch bị giãn.

+ Phẫu thuật Boerama: Khâu thắt hai đầu tĩnh mạch bị giãn và tiêm Glucose 60%.

+ Phẫu thuật ngăn cản luồng máu nối tiếp cửa - chủ đi qua thực quản.

+ Phẫu thuật Tanner: Cắt ngang dạ dày, sau đó khâu nối lại. Wangensteen cải tiến cắt đi một phần đáy dạ dày.

+ Phẫu thuật Phémister -Humphreys: Cắt 1/3 dưới thực quản và một phần dạ dày dưới tâm vị sau đó đưa ruột lên nối lại.

+ Phẫu thuật Moredino: Cắt một phần thực quản trên tâm vị và dưới tâm vị rồi ghép một đoạn ruột non có cuống mạch nuôi.

+ Phẫu thuật Wosshulte: Thắt ngang thực quản trên tâm vị đè lên một dụng cụ đặc biệt gọi là van Wosshulte hoặc ống cải tiến của Nguyễn Khánh Dư.

- Điều trị cổ trướng:

+ Dẫn lưu dòng nước cổ trướng vào tổ chức dưới da: Thường mang lại ít kết quả và không lâu dài (trong vòng 6 tháng).

zalo nhóm duy nhất 0528112107

+ Dẫn lưu nước cổ trướng vào tĩnh mạch: Phẫu thuật có kết quả nhất là dẫn lưu nước cổ trướng vào tĩnh mạch chủ dưới qua hệ thống van một chiều (van Spitz - Holter). Kết quả sau mổ nước cổ trướng giảm rõ rệt, trạng thái toàn thân khá lên.

+ Phẫu thuật dẫn lưu ống ngực: Nối ống ngực với một tĩnh mạch nào đó.

+ Cắt bỏ tuyến thượng thận hai bên.

* Ghép gan:

Ghép gan được chỉ định chủ yếu trong hai bệnh cảnh chính là suy gan và ung thư gan. Đối với xơ gan gây tăng áp lực tĩnh mạchcửa thì chỉ định ghép trong bệnh lý *xơ gan* mất bù hoặc CMĐTH do tăng áp lực tĩnh mạchcửa tái phát nhiều lần.

5.9. Biến chứng

- Khi sử dụng các thuốc chẹn beta giao cảm không chọn lọc cần phải theo dõi chặt chẽ về huyết áp và tần số mạch. Thuốc có thể làm giảm tần số mạch xuống dưới 60 lần/phút.

- Cầm máu qua nội soi bằng tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản có hiệu quả không cao và nhiều biến chứng hơn so với thắt bằng vòng cao su như gây loét, hoại tử chảy máu búi giãn… Tỷ lệ tái phát búi giãn sau thắt là 64,8% cao hơn so với nhóm tiêm xơ 57%.

- Phẫu thuật phân lưu cửa chủ có hiệu quả làm giảm tỷ lệ chảy máu. Biến chứng sau phẫu thuật hay gặp là hội chứng não gan, chảy máu tái phát, thậm chí tử vong. Vì thế phẫu thuật phân lưu cửa chủ ít được khuyến cáo thực hiện trong điều trị dự phòng chảy máu do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản tiên phát ở bệnh nhân xơ gan.

5.10. Điều trị dự phòng

CMĐTH do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản làm tăng nguy cơ tử vong từ 15-20% ở bệnh nhân có rối loạn chức năng gan nặng. Nếu bệnh không được điều trị thì chỉ 30-40% bệnh nhân sống thêm hai năm sau khi bị xuất huyết lần đầu. Theo Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ (AASLD), để làm giảm và dự phòng nguy cơ chảy máu do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản cần lưu ý:

1. Xơ gan không giãn tĩnh mạch thực quản thì không dùng chẹn beta không chọn lọc để ngăn chặn sự phát triển của búi giãn tĩnh mạch.

2. Xơ gan còn bù, giãn tĩnh mạch nhỏ không chảy máu nhưng có nguy cơ xuất huyết (Child Pugh B/C hoặc có các dấu chấm đỏ trên tĩnh mạch giãn nhìn thấy qua nội soi), chẹn beta không chọn lọc nên được sử dụng để phòng ngừa xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch tiên phát.

3. Xơ gan, giãn tĩnh mạch nhỏ không chảy máu và không có nguy cơ xuất huyết, có thể sử dụng chẹn beta không chọn lọc, mặc dù lợi ích lâu dài chưa được chứng minh.

4. Giãn tĩnh mạch nhỏ, không chảy máu, không dùng chẹn beta: Soi thực quản-dạ dày 2 năm/lần. Nếu có bằng chứng xơ gan mất bù: Soi thực quản-dạ dày tại thời điểm đó và lặp lại mỗi năm/lần.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

5. Giãn tĩnh mạch nhỏ hoặc đang dùng chẹn beta: Không cần thiết lặp lại soi thực quản-dạ dày.

6. Giãn tĩnh mạch trung bình hoặc lớn, không chảy máu nhưng có nguy cơ cao xuất huyết: Sử dụng chẹn beta không chọn lọc (propranolol hoặc nadolol) hoặc thắt vòng cao su búi giãn tĩnh mạch thực quản được khuyến cáo để phòng ngừa xuất huyết tiên phát.

7. Giãn tĩnh mạch trung bình hoặc lớn, không chảy máu và không có nguy cơ cao xuất huyết (Child Pugh A và không có dấu chấm đỏ): Nên dùng chẹn beta không chọn lọc nhưng nếu có chống chỉ định hoặc không dung nạp hay không tuân thủ chẹn beta thì xem xét thắt búi giãn qua nội soi.

8. Đang dùng chẹn beta không chọn lọc: Cần chỉnh liều dung nạp tối đa, không cần thiết lặp lại soi thực quản-dạ dày.

9. Thắt búi giãn cần phải lặp lại mỗi 1-2 tuần/lần cho đến khi ổn định và theo dõi bằng cách soi thực quản-dạ dày 1-3 tháng, sau đó soi 6-12 tháng/lần để kiểm tra giãn tĩnh mạch tái phát.

10. Nitrates đơn trị liệu hoặc phối hợp chẹn beta không chọn lọc, tạo shunt nối cửa chủ hoặc tiêm xơ tĩnh mạch thực quản không nên áp dụng để dự phòng chảy máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản tiên phát.

5.11. Kết luận

CMĐTH do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản trên bệnh nhân xơ gan có tiên lượng xấu, tỉ lệ tử vong từ 20-80%. Điều trị dự phòng là biện pháp hữu hiệu giúp giảm tỉ lệ chảy máu. Điều trị dự phòng tiền tiên phát, tiên phát và thứ phát với thuốc ức chế beta hoặc thắt tĩnh mạch thực quản hoặc kết hợp cả hai. Mỗi giai đoạn nên chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp như sử dụng thuốc ức chế thụ thể beta, thuốc giãn mạch nhóm nitrat, thắt búi giãn tĩnh mạch bằng vòng cao su qua nội soi, tiêm xơ búi giãn, phẫu thuật tạo shunt hoặc ghép gan.

6. Một số nguyên nhân gây chảy máu khác

6.1. Hội chứng Mallory - Weiss

- Tổn thương rách niêm mạc dạ dày ở vùng tâm vị do nôn nhiều, thoát vị hoành.
- Nội soi: Xác định vết xước ở gần tâm vị về phía dạ dày, dài 1 - 3cm. Thường có một vết rách, 15 % có nhiều vết rách.
- Điều trị: Chủ yếu là điều trị nội khoa, 80% ngừng chảy tự nhiên. Nếu nội soi thấy tiếp tục chảy có thể tiêm xơ hoặc phẫu thuật Nissen.

6.2. Viêm thực quản

Phần lớn là dạng viêm loét nông, trợt, điều trị bằng thuốc bọc niêm mạc (Gaviscon), giảm acid (Maalox), thuốc ức chế H_2 (Cimetidin và Primperan).

6.3. Loét thực quản

Thường là loét Barret do viêm trào ngược thực quản. Điều trị nội khoa ít tác dụng, nên chỉ định phẫu thuật để điều trị triệt để hơn.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

6.4. Các loại u thực quản

Ung thư thực quản, u lành dạ dày (Schwannome, Leiomyome) ít gặp.

VI. CHẢY MÁU ĐƯỜNG TIÊU HÓA GIỮA (CMĐTHG)

1. Đại cương

Hầu hết CMĐTH xảy ra từ đường tiêu hóa trên và dưới. CMĐTHG là chảy máu ở ruột non từ dưới bóng Vater đến van hồi tràng, chiếm khoảng 5 - 10% trong tất cả các trường hợp CMĐTH, là nguyên nhân ít gặp nhưng khó xác định và khó xử trí nhất trong các loại CMĐTH. CMĐTHG là một thách thức đối với bác sĩ tiêu hóa mặc dù hiện nay có nhiều công cụ chẩn đoán và điều trị khác nhau.

2. Định nghĩa

CMĐTHG là những chảy máu từ dưới bóng Vater tới góc hồi manh tràng hay chảy máu ở ruột non.

3. Bệnh nguyên

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên CMĐTHG.

Ở tuổi dưới 40: Các nguyên nhân phổ biến nhất là bệnh Crohn, tổn thương dị dạng mạch Dieulafoy, u ruột non, viêm túi thừa Meckel và viêm polyp (polyposis); các khối u ruột non có thể là lành tính hoặc ác tính; u lành tính gồm u mô đệm kích thước nhỏ <2cm (GIST), u thần kinh lành tính (carcinoid), hemangioma, adenoma, leiomyoma, lipoma và neurofibroma; u ác tính gồm GIST lớn, ung thư biểu mô tuyến, ung thư hạch, khối u thần kinh ác tính, ung thư bạch cầu và khối u di căn từ khối u ác tính khác như từ phổi hoặc vú. Hội chứng đa polyp (polypose) ở ruột non, một số polyp tuyến thượng thận, hội chứng Peutz-Jeghers…

Ở tuổi trên 40: Các nguyên nhân phổ biến nhất là đau thắt ngực, loét do thuốc NSAIDs, tổn thương Dieulafoy và khối u ruột nhỏ. Hiếm gặp hơn là túi thừa ruột non, giãn tĩnh mạch ruột non, giãn mạch máu di truyền, xuất huyết di truyền, Kaposi, sarcoma, lao ruột, viêm ruột, amyloidosis, bệnh Behcet, pseudoxanthoma và hội chứng Ehlers-Danlos. Tỷ lệ khối u thần kinh ruột non (SBNET) đã gia tăng trong vài thập kỷ qua và hiện nay chúng được coi là khối u ác tính nguyên phát phổ biến nhất của ruột non. Adenocarcinomas thường thấy ở hỗng tràng; SBNET và lymphoma thường nằm ở hồi tràng. Sarcomas (khối u trung mô GIST và không GIST của mạc treo: leiomyosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma, Kaposi, angiosarcoma) đều nằm ở ruột non.

4. Chẩn đoán

Tiền sử: Truyền máu nhiều lần do thiếu máu bán cấp hoặc mạn tính.

Lâm sàng:

- Ù tai, chóng mặt, hoa mắt, hồi hộp, nhịp tim nhanh, dễ mệt, có khi bị ngất.
- Chán ăn, rối loạn tiêu hóa.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Rối loạn nội tiết: Nữ có thể vô kinh.

- Ỉa phân đen, đôi khi có thể ỉa máu tươi.

- Nôn ra máu nếu tổn thương gần góc Treitz.

- Không thấy nôn ra máu hoặc ỉa phân đen nhưng có dấu hiệu thiếu máu biểu hiện da xanh, niêm mạc nhợt, viêm lưỡi teo và móng tay lõm lòng thuyền, xét nghiệm phân có máu.

Cận lâm sàng:

- Xét nghiệm hồng cầu, Hb, Hct giảm, ferritin giảm.

- Nội soi viên nang video (VCE), nội soi đẩy, nội soi hỗ trợ thiết bị (DAE), chụp cắt lớp đa dãy (CTE), chụp cộng hưởng từ (MRI), Meckel's scan (tiêm dược chất phóng xa Technetium-99m để chụp scintigraphy), chụp động mạch, thậm chí soi ổ bụng để chẩn đoán.

5. Điều trị phẫu thuật

- Ung thư biểu mô ruột non kết hợp hóa trị bổ trợ.

- Khối u lành tính (adenoma), u GIST, u trung mô không GIST, lipoma, leiomyoma, hamartomas, hội chứng Peutz-Jeghers, các khối u di căn đến ruột non, viêm túi thừa Meckel...

VII. CHẢY MÁU ĐƯỜNG TIÊU HÓA DƯỚI (CMĐTHD)

1. Đại cương

CMĐTHD chiếm 30 - 40% các trường hợp CMĐTH, trong đó khoảng 85% liên quan đến đại tràng sigma và trực tràng. Biểu hiện lâm sàng của CMĐTHD chủ yếu là ỉa phân máu cá hoặc máu tươi. CMĐTHD có xu hướng ít nghiêm trọng hơn so với CMĐTHT, thường tự ngừng và không liên tục.

2. Định nghĩa

Chảy máu đường tiêu hóa dưới là tổn thương gây chảy máu từ góc hồi manh tràng tới ống hậu môn. Biểu hiện lâm sàng của CMĐTHD là đi ngoài ra phân có máu đỏ.

3. Nguyên nhân

- Vỡ búi trĩ: Ít gặp nhưng gây chảy máu dữ dội, kéo dài.

- Ung thư đại trực tràng, hay gặp nhất là đại tràng sigma - trực tràng.

- Viêm túi thừa chảy máu, thường gặp ở đại tràng sigma và trực tràng.

- Dị dạng mạch máu đại tràng, u lành, polyp đại tràng...

- Tỷ lệ bệnh lý gây chảy máu ở đại tràng, theo Ali Tavakkolizadeh [3] là: 5-10% do thiếu máu cục bộ; 5-15% bệnh lý hậu môn trực tràng; 5-10% u đại trực tràng; 3-8% viêm đại tràng có tính chất gia đình; 3-7% sau phẫu thuật cắt bỏ đại tràng; 3% sinh lý mạch máu; 1-3% viêm đại tràng; 1-5% các nguyên nhân khác; 10-25% chưa rõ nguyên nhân.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

4. Chẩn đoán

- Đau bụng cơn, ỉa lòng hoặc táo bón, phân như máu cá hoặc máu đỏ tươi.
- Khám bụng có thể sờ thấy khối u.
- Thăm trực tràng thấy búi trĩ chảy máu hoặc khối u trong lòng trực tràng.
- Soi đại tràng để xác định chẩn đoán, đôi khi có thể can thiệp để cầm máu như kẹp clip, đốt điện, cắt polyp…

5. Điều trị

Tùy thuộc nguyên nhân và mức độ chảy máu mà chỉ định cắt đoạn đại tràng (cấp cứu hoặc trì hoãn) để loại bỏ nguyên nhân gây chảy máu.

Có thể điều trị nội khoa hoặc nếu tình trạng huyết động ổn định có thể mổ phiên.

VIII. KẾT LUẬN

- CMĐTH là biến chứng của nhiều loại tổn thương, diễn biến phức tạp có thể từ mức độ nhẹ sang nặng.
- Bệnh nhân phải nằm viện theo dõi chặt chẽ, hồi sức tích cực khi chảy máu nặng.
- Chẩn đoán phải có sự thống nhất giữa phẫu thuật viên, bác sỹ nội soi, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức để có chỉ định điều trị hợp lý.
- Trong CMĐTHG và CMĐTHD cần thăm trực tràng, soi hậu môn trực tràng hoặc nội soi toàn bộ đại tràng. Nếu không thấy tổn thương gây chảy máu ở đại trực tràng thì mới tiến hành các thăm dò khác như nội soi viên nang video (VCE), nội soi đẩy, nội soi hỗ trợ thiết bị (DAE), chụp cắt lớp đa dãy (CTE), chụp cộng hưởng từ (MRI), Meckel's scan (tiêm dược chất phóng xạ Technetium-99m để chụp scintigraphy), chụp động mạch thậm chí soi ổ bụng để chẩn đoán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Monjur Ahmed (*2019*). Mid-Gastrointestinal Bleeding, *Gastrointestinal Bleeding, Intechopen.*
2. Ell C, May A. (*2006*) Mid-gastrointestinalbleeding: Capsule endoscopy andpush-and-pull enteroscopy give riseto a new medical term. *Endoscopy;38(1):73-75*
3. Sabiston (*2012*). Texbook of surgery: the Biological basis of modern Surgical Practice. *19th Edition, Elsevier sauders, 1161-1181.*
4. Andres Sanchez-Yague (*2015*). Chapter 32: Middle gastrointestinal bleeding. *Book Editor(s): Tony C. K. Tham John S. A. Collins Roy Soetikno, First published: 20 November.*
5. Mönkemüller K.[a,b] · Neumann H.[b] · Fry L.C.[a,b] (*2010*). Middle Gastrointestinal Bleeding. *Gastrointestinal Endoscopy. Front Gastrointest Res. Basel, Karger, vol 27, pp 221–239.*

zalo nhóm duy nhất 0528112107

6. Palmer K (2016). Acute upper non-variceal gastrointestinal hemorrhage.*Gastrointestinal Emergencies, John Wiley & Son, pp. 151- 157.*

7. Cappell MS., Friedel D. (2008). Initial management of acute upper gastrointestinal bleeding: from initial evaluation up to gastrointestinal endoscopy.*Med Clin North Am. 2008 May;92(3):491-509.*

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Phân loại chảy máu đường tiêu hóa?

Câu 2. Các bước xử trí ban đầu chảy máu đường tiêu hóa?

Câu 3. Nguyên nhân thường gặp trong chảy máu đường tiêu hóa trên?

Câu 4. Các giai đoạn điều trị dự phòng chảy máu đường tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa?

Câu 5. Những khuyến cáo của Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ (AASLD) trong điều trị dự phòng chảy máu đường tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa?

Câu 6. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh nào thường được sử dụng trong chảy máu đường tiêu hóa giữa?

Câu 7. Hội chứng Dieulafoy là hội chứng gì?

zalo nhóm duy nhất 0528112107